

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ

Οι τροπονίνες είναι καρδιακές ρυθμιστικές πρωτεΐνες που βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα των μυοκαρδιακών κυττάρων. Το σύμπλεγμα της τροπονίνης αποτελείται από τρεις υπομονάδες: cTnC, cTnI και cTnT. **Η cTnI έχει δείχθει ότι είναι εξαιρετικά ειδική για τον καρδιακό μυ.**

Τα αίτια και οι μηχανισμοί των αυξημένων συγκεντρώσεων των καρδιακών τροπονινών cTnT και cTnI είναι πολυάριθμα και δεν περιορίζονται στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (OEM), είτε αφορά STEMI, είτε NSTEMI. Οποιοσδήποτε τύπος, αναστρέψιμης ή μη, μυοκαρδιακής βλάβης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα cTnT και cTnI ορού. Οι μετρήσεις της cTnI βρέθηκαν να παρουσιάζουν σχεδόν 100% ευαισθησία όταν ελέγχονται στις 6-12 ώρες μετά την έναρξη του θωρακικού άλγους κι έχουν σημαντικά υψηλή ειδικότητα ως προς τη βλάβη του καρδιακού μυός σε σύγκριση με άλλους βιοδείκτες (π.χ. AST, LDH, CK, CK-MB) που χρησιμοποιούνται ακόμα.

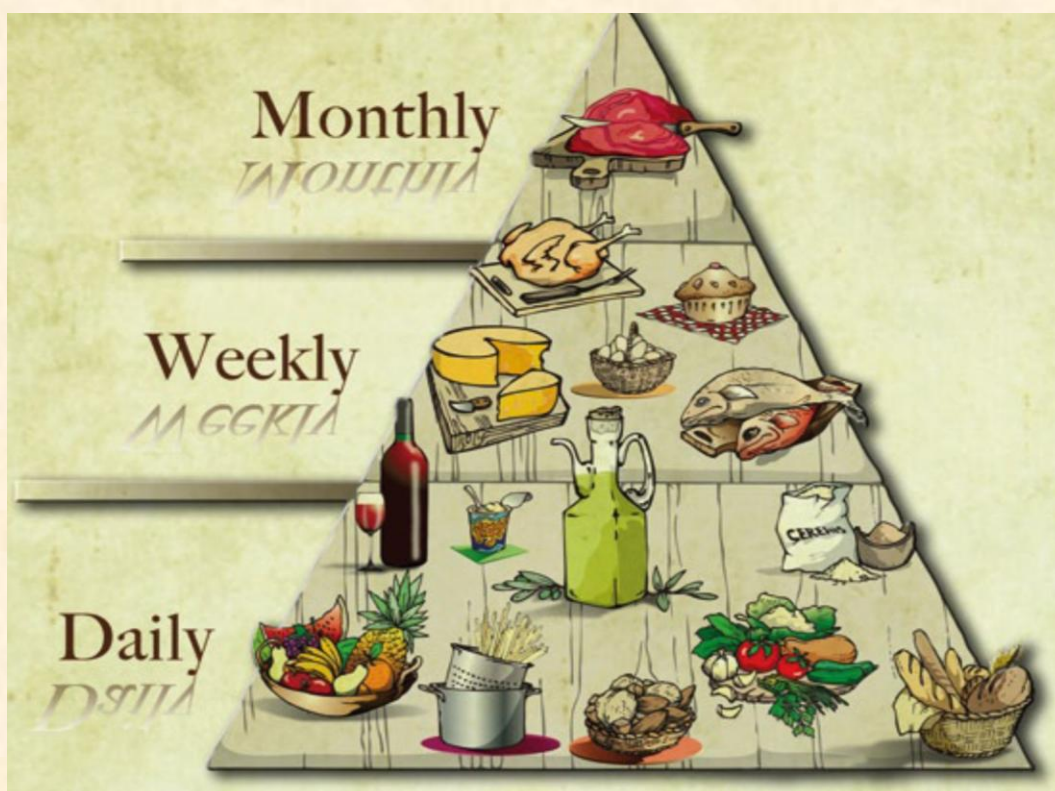
Το NSTEMI ορίζεται ως βλάβη του καρδιακού μυός η οποία οδηγεί σε αυξημένη τροπονίνη, αλλά στερείται των μορφολογικών αλλαγών του ΗΚΓ που προσδιορίζουν ένα STEMI.

Τα Non-STEMI αποτελούν πρόκληση για τον ιατρό των Επειγόντων. Πιθανώς, ένας ασθενής με προκάρδιο άλγος να έχει αρχικά αρνητική μέτρηση τροπονίνης, χωρίς αλλαγές στο ΗΚΓ, αλλά μπορεί να εμφανίζει NSTEMI, επειδή τα επίπεδα της τροπονίνης αρχίζουν να αυξάνονται τουλάχιστον 2 έως 3 ώρες μετά την αρχική προσβολή. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης 2-3 διαδοχικών δειγμάτων τροπονίνης, με απόσταση 3 έως 6 ωρών, σε ασθενείς του ΤΕΠ που παρακολουθούνται στη MBN και για τους οποίους υπάρχει η βάσιμη υποψία ότι έχουν υποστεί ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο, αλλά έχουν μια τιμή τροπονίνης που αρχικά είναι φυσιολογική.

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί αύξηση των καρδιακών τροπονινών, ακόμα και επί απουσία βλάβης στα μυοκαρδιακά κύτταρα. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματίες υγείας δεν πρέπει να αγνοούν τα δεδομένα σχετικά με την πιθανότητα αύξησης των τιμών (cTnI > 0,4 ng/ml ή hs-cTnI > 14 ng/L) των καρδιακών τροπονινών σε άλλες ασθένειες ή νοσηρές καταστάσεις.

ΑΙΤΙΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ	
Άμεσα καρδιακά αίτια	Έμμεσα καρδιακά αίτια
• Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (OEM). • Φλεγμονώδεις καρδιοπάθειες (ενδοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, Kawasaki). • Βαριά χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. • Βραδυ- & ταχυαρρυθμίες (AF, SVT). • Καρδιοανάταξη. • Οξύς Αορτικός διαχωρισμός. • Τραυματική καρδιακή κάκωση. • Φάρμακα (ανθρακυκλίνες, αντιμεταβολίτες). • Μετά από PCI, χωρίς επιπλοκές. • Μετά από CABG, χωρίς επιπλοκές. • Σύνδρομο Takotsubo. • Νοσήματα της αορτικής βαλβίδας. • Διηθητικά καρδιακά νοσήματα (Αμυλοείδωση).	• Σοβαρές φλεγμονές - Σήψη. • Νόσοι του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΑΕΕ, υπαραχνοειδής αιμορραγία, επιληψία). • Πνευμονική εμβολή. • Λοίμωξη Covid-19. • Αμβλύ θωρακικό τραύμα. • Κακοήθειες. • Βαριά παρόξυνση ΧΑΠ ή άσθματος. • Βαριά πνευμονική υπέρταση. • Βαριά εμμένουσα αναιμία. • Φαιοχρωμοκύττωμα. • Σοβαρή εμμένουσα αρτηριακή υπέρταση. • Βαριά εμμένουσα αρτηριακή υπόταση. • Μείζον έγκαιμα με TBSA > 30%.
ΑΙΤΙΕΣ ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ	
▶ Ετερόφιλα αντισώματα (IgM: EBV, CMV, TORCH) ▶ Ρευματοειδής παράγοντας (RF). ▶ Υψηλές τιμές αλκαλικής φωσφατάσης (ALP). ▶ Ασθενείς που λαμβάνουν βιοτίνη. ▶ Υποθυρεοειδισμός. ▶ Κίρρωση ήπατος. ▶ Ανοσοθεραπείες.	▶ Νεφρική ανεπάρκεια. ▶ Αιμόλυση. ▶ Διαβητική κετοξέωση. ▶ Δηλητήριο σκορπιού & φιδιών. ▶ Έντονη άσκηση & stress. ▶ Ραβδομυόλυση & οξεία νεφρική βλάβη. ▶ Βλάβες του βιοχημικού αναλυτή.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΝΟΣΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



«Ου γὰρ ἀναιρείται τὸ ζῆν, οὐδὲ βίος ἀπόλλυται τοῖς ἀνθρώποις,
ἀν μὴ λοπάδας ἰχθύων μὴδ' ἥπατα χηνῶν ἔχωσι.»

Δεν ακυρώνεται ἡ ζωὴ, οὔτε καταστρέφονται οἱ ἄνθρωποι,
ὅταν δὲν ἔχουν πιατέλες με ψάρια καὶ συκώτια χήνας.

Πλούταρχος (47-120 μ.Χ.)